

EXAMEN D'EVALUATION 1

1. La prise en charge de la schizophrénie associe

- A. La réintégration sociale du patient
- B. La prescription d'un thymorégulateur
- C. La prescription d'un antipsychotique
- D. Une psychothérapie
- E. La prescription d'un anxiolytique

2. Le signe qui caractérise la dissociation affective est

- A. Des suspensions du cours des idées
- B. Des contaminations d'une idée par une autre
- C. Des idées de persécution et d'ensorcellement
- D. Une perte de l'élan vital
- E. Un contact de bonne qualité

3. Le syndrome dissociatif :

- A. Est une caractéristique spécifique de la schizophrénie
- B. Ne touche que l'affect et le comportement
- C. Est responsable du caractère paranoïde du délire
- D. Peut être à l'origine des réactions émotionnelles brutales
- E. Touche les facultés d'attention et de concentration

4. La confusion mentale :

- A. comporte une altération importante de l'état de conscience
- B. Signe une souffrance spécifique du cerveau
- C. se caractérise par une résolution spontanée de la symptomatologie
- D. l'onirisme est toujours présent
- E. est un état pathologique d'installation aiguë

5. Les étiologies d'une dépression secondaire sont

- A. Hypothyroïdie
- B. Accident vasculaire cérébral
- C. Epuisement professionnel
- D. Adénome de la prostate
- E. Antihypertenseurs centraux

6. Les signes suivants sont observés dans la dépression névrotique

- A. Un ralentissement psychomoteur sévère
- B. Des antécédents de conversion
- C. Une insomnie d'endormissement
- D. L'absence de réactivité de l'humeur
- E. Une aggravation vespérale



7. Les symptômes suivants permettent de retenir le diagnostic d'une dépression délirante

- A. Un syndrome de Cotard
- B. L'apparition des symptômes dépressifs avant les symptômes délirants
- C. Début progressif
- D. Des obsessions idéatives
- E. L'existence de syndrome dissociatif

8. Un syndrome maniaque se caractérise par

- A. Fuite des idées
- B. Logorrhée
- C. Ludisme
- D. Anxiété permanente
- E. Stéréotypies verbales

9. Au cours de l'embolie pulmonaire

- A. On observe un effet shunt
- B. On observe un effet espace mort
- C. Une hypoxémie et une hypercapnie sont souvent notées
- D. L'hypertension artérielle pulmonaire est irréversible
- E. L'élévation des troponines peut se voir en rapport avec le bas débit cardiaque

10. A propos de l'hydatidose hépatique:

- A. l'hôte intermédiaire est le chien
- B. contient à l'intérieur un embryophore
- C. correspond chez l'homme à une impasse parasitaire.
- D. l'hôte définitif peut-être un bovin, un mouton ou un dromadaire
- E. est lié à la présence dans l'organisme de larves d'Echinococcus granulosus

11. En imagerie, le kyste hydatique hépatique type IV:

- A. pose un problème de diagnostic différentiel avec les tumeurs hépatiques
- B. possède une paroi partiellement calcifiée
- C. s'accompagne d'une aérobilie
- D. peut s'associer à d'autres localisations intra hépatiques
- E. se complique d'une thrombose porte

12. Dans le kyste hydatique infecté :

- A. on peut observer un niveau hydro-aérique sous phrénique droit à l'abdomen sans préparation
- B. il peut s'agir d'un KHF type I
- C. il peut s'agir d'un KHF type III
- D. la fissuration dans les voies biliaires est constante
- E. le traitement antibiotique peut suffire à juguler l'infection



13. La complication la plus fréquente d'un kyste hydatique du foie est

- A. l'ouverture dans le thorax
- B. l'infection
- C. l'ouverture dans les voies biliaires
- D. la rupture dans le péritoine
- E. la compression vasculaire

14. Le scanner est particulièrement indiqué dans le kyste hydatique du foie en cas de

- A. kyste unique type IV à l'échographie
- B. suspicion de récurrence hydatique
- C. kystes hydatiques multiples
- D. kyste unique type III à l'échographie
- E. kyste hydatique ouvert dans le thorax

15. Les pathologies oculaires suivantes sont révélées par un tableau d'œil rouge non douloureux

- A. Kératite aiguë
- B. Hémorragie sous-conjonctivale
- C. Crise de glaucome aigu par fermeture de l'angle
- D. Conjonctivite
- E. Uvéite antérieure

16. Devant un tableau d'œil rouge, les signes qui évoquent le diagnostic de crise aiguë de glaucome primitif par fermeture de l'angle sont

- A. Douleur intense
- B. Rougeur périkeratique
- C. Myosis
- D. Oedème cornéen
- E. Hypertonie oculaire

17. Devant une rougeur oculaire, les éléments suivants constituent un signe de gravité

- A. Rougeur périkeratique
- B. Notion de traumatisme oculaire récent
- C. Anomalie pupillaire
- D. Hypertonie oculaire
- E. Rougeur diffuse associée à des sécrétions

18. Devant une rougeur oculaire avec douleur chez un patient opéré d'une cataracte il y a 5 jours, le premier diagnostic à évoquer est

- A. Crise de glaucome par fermeture de l'angle
- B. Uvéite antérieure aiguë
- C. Glaucome néovasculaire
- D. Endophtalmie aiguë
- E. Kératite



19. La crise d'asthme :

- A. survient fréquemment en pleine journée
- B. **est souvent précédée par certains prodromes**
- C. la résolution de la crise nécessite toujours l'administration d'un traitement bronchodilatateur
- D. L'examen physique trouve une bradypnée inspiratoire
- E. **Elle peut être déclenchée par l'exposition à de la fumée de tabac**

20. Devant une dyspnée sifflante, les diagnostics à évoquer sont :

- A. Une pleurésie
- B. **Un asthme bronchique**
- C. **Une BPCO**
- D. Un adénocarcinome broncho pulmonaire périphérique
- E. **Un dysfonctionnement des cordes vocales**

21. Les Béta 2 stimulants :

- A. entraînent une broncho-dilatation jusqu'aux voies aériennes proximales seulement
- B. **améliorent l'activité muco-ciliaire**
- C. améliorent la contractilité du diaphragme
- D. **peuvent entraîner une hypokaliémie**
- E. Les Béta 2 LA (longue durée d'action) ne sont indiqués qu'en traitement de fond

22. L'indication thérapeutique d'un cancer broncho-pulmonaire dépend :

- A. **du type histologique**
- B. **de l'âge chronologique**
- C. **du terrain**
- D. **du stade de la maladie**
- E. du taux des marqueurs tumoraux

23. Les caractéristiques sémiologiques suivantes vous orientent vers une douleur d'un syndrome coronarien aigu avec sus décalage persistant de ST (SCA ST (+)) :

- A. basithoracique, augmentant à l'inspiration profonde
- B. latérothoracique en coup de poignard
- C. **rétrosternale, constrictive, irradiant à la mâchoire et à l'avant-bras gauche**
- D. fugace et récidivante, de l'ordre de quelques minutes
- E. **persistante et prolongée, depuis plus de 20 minutes, non modifiée par la prise de dérivés nitrés**

24. Devant un SCA ST(-), quelles sont les deux conditions pour lesquelles les propositions suivantes qui permettent d'envisager si la recherche d'ischémie est possible à distance sans coronarographie d'emblée ?



24. Devant un SCA ST(-), quelles sont les deux conditions parmi les propositions suivantes qui permettent d'envisager si une recherche d'ischémie est possible à distance sans coronarographie d'emblée ?

- A. pas de récurrence de douleur thoracique
- B. décompensation cardiaque modérée
- C. modification électriques à l'ECG avec ondes T négatives (pas de sus-décalage du segment ST)
- D. cycle de troponine normal
- E. NT-pro BNP normal

25. A propos du syndrome coronarien aigu avec sus décalage persistant de ST (SCA ST (+)). Quel est parmi les 5 propositions suivantes, celle qui est inexacte ?

- A. on peut observer des infarctus sans sténose athéromateuse visible à la coronarographie
- B. les dosages enzymatiques concourent au diagnostic, dès la 1ère heure
- C. les troubles de conduction sont fréquents dans les localisations inférieures
- D. certains sont indolores
- E. les signes électrocardiographiques peuvent être masqués par la présence d'un bloc de branche gauche

26. Quels sont parmi ces propositions les critères de succès de la revascularisation par fibrinolyse ?

- A. Disparition de la douleur
- B. Pic retardé de troponines US à H8
- C. Décroissance du sus-décalage de ST > 50%
- D. Rythme idioventriculaire accéléré
- E. Disparition de l'image en miroir

27. Les molécules ou classes pharmacologiques anti-thrombotiques suivantes sont utilisables lors de la prise en charge initiale d'un syndrome coronaire aigu sans sus décalage de ST :

- A. Aspirine
- B. Antivitamine K
- F. Prasugrel
- G. Héparine de bas poids moléculaire
- H. Antagoniste des récepteurs glycoprotéiques IIb-IIIa

28. La confusion mentale :

- A. A un début brutal
- D. Est plus fréquente chez le sujet âgé



28. **La confusion mentale :**

- A. **A un début brutal**
- B. **Est plus fréquente chez le sujet âgé**
- C. Est plus fréquente chez l'homme
- D. **Témoigne d'une souffrance cérébrale**
- E. Est une psychose chronique

29. **Le délirium Tremens :**

- A. **Est une complication du sevrage de l'éthylisme chronique**
- B. Est secondaire à une démence vasculaire
- C. **Met en jeu le pronostic vital**
- D. **Nécessite la mise en route d'une réhydratation**
- E. **Peut être prévenu par un traitement à base de benzodiazépines et de vitamines du groupe B**

30. **Les signes évocateurs de la confusion mentale sont :**

- A. **Une désorientation temporo-spatiale**
- B. **Des troubles de l'attention**
- C. Un délire de grandeur
- D. **Un onirisme**
- E. Une amélioration vespérale

31. **La séquence thérapeutique adéquate pour une tumeur du rectum situé à 5 cm de la marge anale qui atteint le mésorectum sans le dépasser et qui est associé à une atteinte ganglionnaire sans métastase à distance est**

- A. radiochimiothérapie néoadjuvante suivie d'amputation abdomino-perinéale
- B. une amputation abdomino-perinéale suivie de chimiothérapie adjuvante.
- C. **une radio chimiothérapie néo-adjuvante suivie d'une résection antérieure du rectum.**
- D. une résection antérieure du rectum suivie de chimiothérapie adjuvante
- E. une chimiothérapie palliative

32. **La douleur thoracique dans la dissection aortique:**

- A. **Constitue le signe fonctionnel le plus fréquent**
- B. **Est d'installation brutale**
- C. Est typiquement à type de constriction ou de brûlure
- D. Le caractère migrateur est constant
- E. Toutes les propositions sont justes

33. **L'évaluation de base initiale pour tous les patients avec une suspicion clinique de péricardite aiguë doit inclure :**

- A. Uniquement l'ECG
- B. ECG et échographie cardiaque
- C. ECG et radiographie du thorax
- D. ECG et biologie standard



E. ECG, Radiographie du thorax, échographie cardiaque, marqueurs biologiques de l'inflammation et de nécrose myocardique

34. Les pathologies responsables d'une douleur thoracique classiquement exacerbée par l'inspiration profonde et la toux sont

- A. Pleurésie purulente
- B. Infarctus pulmonaire
- C. Péricardite aiguë
- D. Dissection aortique
- E. Névralgie intercostale

35. Le dosage des D-Dimères dans l'embolie pulmonaire :

- A. A une forte valeur prédictive négative.
- B. Un premier dosage négatif doit être refait 6 heures après.
- C. Sa spécificité diminue avec l'âge du patient.
- D. Sa négativité chez les patients à probabilité élevée permet d'écarter le diagnostic.
- E. Son taux diminue de façon progressive au cours de la grossesse.

36. Au cours de l'hémorragie digestive haute :

- A. l'origine du saignement la plus fréquente est l'estomac ou le D1
- B. les vésicorragies sont fréquentes
- C. le saignement d'origine biliaire est exceptionnel
- D. l'origine ulcéreuse est la cause la plus fréquente
- E. la survenue de rectorragies témoigne du caractère grave et actif du saignement

37. L'hémorragie digestive basse

- A. est définie par un saignement du tube digestif en amont de l'angle de Treitz
- B. est définie par un saignement du tube digestif en aval de l'angle duodénojejunal
- C. se manifeste fréquemment par des rectorragies
- D. peut se manifester par un méléna
- E. l'origine du saignement peut être duodénale

38. Les causes de méléna peuvent être :

- A. une tumeur gastrique
- B. le cancer du rectum
- C. l'angiodysplasie de grêle
- D. la maladie hémorroïdaire
- E. l'ulcère bulbaire

39. Devant un tableau de péritonite généralisée, les signes cliniques en faveur d'une perforation d'un diverticule sigmoïdien sont ?

- A. Début brutal



39. **Devant un tableau de péritonite généralisée, les signes cliniques en faveur d'une perforation d'un diverticule sigmoïdien sont ?**

- A. Début brutal
- B. **Antécédent de diverticulose colique**
- C. Absence de fièvre
- D. **Prédominance des signes en fosse iliaque gauche**
- E. **Pneumopéritoine volumineux à l'ASP**

40. **La présence d'un pneumopéritoine sur l'ASP :**

- A. **Doit faire suspecter le diagnostic d'une péritonite aiguë**
- B. Doit faire réaliser un scanner abdominal pour confirmer le diagnostic d'une péritonite aiguë
- C. **Est un croissant gazeux sous phénique en rapport avec l'issue de gaz digestif dans la cavité péritonéale**
- D. Est constant en cas de perforation d'un ulcère gastro-duodénal
- E. **Confirme la perforation d'un organe creux**

41. **Dans une péritonite aiguë secondaire, le mécanisme le plus fréquent d'infection de la séreuse péritonéale :**

- A. Par effraction traumatique.
- B. **Par suppuration d'un organe intra-abdominal...**
- C. Par rupture intra-abdominale d'une suppuration.
- D. Par voie sanguine.
- E. Par voie lymphatique.

42. **Une péritonite aiguë généralisée par diffusion :**

- A. Est une péritonite primitive.
- B. **Peut compliquer une appendicite aiguë.**
- C. N'entraîne pas de séquestration liquidienne.
- D. **Est habituellement poly microbienne.**
- E. **Peut entraîner un choc septique**

43. **Les signes radiologiques suivants, traduisent un iléus biliaire :**

- A- croissant clair gazeux sous-diaphragmatique
- B- **images hydroaériques de l'intestin grêle**
- C- **aérobilie**
- D- élargissement des gouttières pariéto-coliques
- E- image de pariétographie gazeuse des anses grêles

44. **L'occlusion colique par strangulation est caractérisée par**

- A. **Début brutal**
- B. **Douleurs abdominales intenses**
- C. **Arrêt précoce du transit**
- D. Vomissements fréquents
- E. Météorisme abdominal diffus et symétrique



45. Les étiologies des occlusions coliques par obstruction peuvent être :

- A. Un cancer colique
- B. Un volvulus du côlon pelvien
- C. Une bride
- D. Un Phytobézoard
- E. Un fécalome

46. Les étiologies de l'occlusion du grêle par strangulation sont

- A. une bride
- B. Des adhérences
- C. Un iléus biliaire
- D. une tumeur
- E. une invagination intestinale aiguë

47. Une pneumonie à mycoplasmes sera au mieux traitée par les :

- A. Bêta-lactamines
- B. Macrolides
- C. Quinolones
- D. Cyclines
- E. Aminosides

48. Chez un fumeur, la survenue d'une pneumopathie infectieuse fait redouter un cancer bronchique sous-jacent et incite à pratiquer une fibroscopie bronchique quand :

- A. Le tabagisme dépasse les 20 PA
- B. La pneumopathie est due à un germe atypique
- C. La pneumopathie s'abcède
- D. La pneumopathie récidive dans le même territoire
- E. Le sujet est âgé de plus de 40 ans

49. Parmi les facteurs suivants, citez ceux qui favorisent la survenue d'une tuberculose pulmonaire :

- A. La consommation d'alcool
- B. La silicose
- C. La pollution atmosphérique
- D. La promiscuité
- E. La pauvreté

50. La tuberculose pulmonaire commune peut être révélée par :

- A. Un hoquet
- B. Une fièvre au long cours
- C. Une toux chronique
- D. Une dysphonie
- E. Un érythème noueux

51. La tuberculose pulmonaire est :

- A. La plus fréquente des localisations de la tuberculose
- B. Évitable par la vaccination par le BCG



51. **La tuberculose pulmonaire est :**

- A. **La plus fréquente des localisations de la tuberculose**
- B. Evitable par la vaccination par le BCG
- C. La plus grave des localisations de la tuberculose maladie
- D. **Responsable de la propagation de la maladie**
- E. Non guérissable dans la majorité des cas

52. **En cas d'ulcère bulbaire résistant au traitement médical associé à une diarrhée d'apparition récente, vous évoquez le diagnostic suivant**

- A. Cancer du colon
- B. Colopathie fonctionnelle
- C. Diverticulose sigmoïdienne
- D. **Gastrinome (syndrome de Zollinger-Ellison)**
- E. Une perforation

53. **Le diagnostic d'infection à Helicobacter pylori peut être fait par :**

- A. **La sérologie.**
- B. Les hémocultures.
- C. **Le test respiratoire à l'urée (breath test).**
- D. La coproculture.
- E. **L'histologie.**

54. **Chez un patient atteint d'un ulcère gastrique :**

- A. Le traitement d'éradication de l'Helicobacter pylori est systématique
- B. **Le traitement de consolidation par IPP monodose est obligatoire en cas d'ulcère à HP**
- C. **La fibroscopie de contrôle est systématique 4 à 6 semaines de la fin de traitement**
- D. Le contrôle de l'éradication l'Helicobacter pylori n'est pas obligatoire
- E. **Les biopsies de l'ulcère sont obligatoires même après cicatrisation**

55. **Le traitement endoscopique de l'ulcère hémorragique est indiqué si**

- A. **Forrest Ia**
- B. **Forrest Ib**
- C. **Forrest IIa**
- D. Forrest IIc
- E. Forrest III

56. **Parmi les facteurs de risques d'une grossesse extra-utérine**

- A. **Antécédent d'une grossesse extra-utérine**
- B. **Antécédent d'une pathologie tubaire**
- C. **La contraception micro progestative**
- D. **Histoire d'une infection pelvienne**
- E. Utilisation de préservatif



57. Parmi les propositions suivantes quelles sont celles qui constituent des facteurs de risque de GEU

- A. La fécondation in Vitro
- B. La contraception par les oestroprogestatifs
- C. L'antécédent d'une infection génitale haute
- D. Le tabagisme
- E. L'antécédent de chirurgie abdominale ou pelvienne

58. Dans les dix premières semaines de la grossesse, les métrorragies peuvent être causées par:

- A. Une grossesse molaire
- B. Une menace d'avortement spontané
- C. Une insertion basse du placenta
- D. Un hématome rétro-placentaire
- E. Une grossesse extra-utérine

59. La grossesse extra-utérine est

- A. L'implantation de l'œuf en dehors de la cavité utérine
- B. Souvent asymptomatique
- C. Une prolifération anormale de trophoblaste
- D. De localisation tubaire dans la majorité des cas
- E. Une grossesse qui peut évoluer à terme

60. En cas de grossesse extra-utérine, le site le plus fréquent est:

- A. L'ovaire
- B. l'ampoule tubaire
- C. L'isthme tubaire
- D. La portion interstitielle de la trompe
- E. Le col utérin

61. La complication la plus fréquente du cancer du côlon sigmoïde :

- A. Abscess péri-sigmoïdien
- B. Fistule colo-vésicale
- C. Occlusion intestinale aiguë
- D. Perforation tumorale
- E. Perforation diastatique

62. Le syndrome du cancer Familial de Lynch :

- A. prédispose à un haut risque de cancer colo-rectal
- B. Est défini par les critères d'Amsterdam
- C. impose une coloscopie de dépistage
- D. impose un examen gynécologique à la recherche d'un cancer génital associé chez la femme
- E. est responsable de 25% des cancers colo-rectaux

63. Le traitement d'une tumeur du sigmoïde sans métastases à distance est :

- A. Une colectomie sigmoïdienne carcinologique



63. **Le traitement d'une tumeur du sigmoïde sans métastases à distance est :**

- A. Une colectomie sigmoïdienne carcinologique
- B. Une chimiothérapie néoadjuvante
- C. Une sigmoïdectomie associée à une radiothérapie adjuvante
- D. Une sigmoïdostomie
- E. Une coloproctectomie

64. **Sont considérés à risque élevé de cancer colo-rectal les sujets :**

- A. Ayant une polypose adénomateuse familiale
- B. Porteurs d'une R.C.H touchant tout le colon
- C. Ayant un parent de premier degré atteint d'un cancer colo-rectal
- D. Porteurs d'une diverticulose colique s'étant compliquée de poussées de diverticulite
- E. Ayant eux même des antécédents d'adénomes réséqués.

65. **La dysplasie cervicale ou néoplasie intra-cervicale :**

- A. Naît au niveau de la jonction pavimento- cylindrique
- B. Est une lésion viro induite
- C. Est fréquente dans la période péri-ménopause
- D. Contre indique toute nouvelle grossesse
- E. Evolue vers un cancer du col en 8 mois

66. **Le cancer in situ du col :**

- A. Est plus fréquent chez la femme de plus de 50 ans
- B. Est strictement limité à la muqueuse.
- C. N'a aucune traduction clinique.
- D. Ne nécessite pas de bilan d'extension.
- E. Peut être traité par une conisation qui passe in sano

67. **Le cancer du col :**

- A. Survient après une dysplasie
- B. Ne survient jamais chez la vierge
- C. associé aux infections par le HPV
- D. Seule la persistance de HPV à haut risque expose au cancer du col.
- E. Le diagnostic repose sur le FCV

Cas cliniques :

Cas clinique 1

Mme A.M âgée de 40 ans consulte pour des céphalées évoluant depuis 20 ans. Ces céphalées sont épisodiques, de durée variable qui peut aller jusqu'à 2 jours. La patiente rapporte que ces épisodes surviennent période menstruelle, associés à des vomissements et parfois des troubles visuels à type de lignes brisées scintillantes, qui durent 30 min juste avant le début des crises. Les céphalées sont décrites comme pulsatiles.

Cas cliniques :

Cas clinique 1

Mme A.M âgée de 40 ans consulte pour des céphalées évoluant depuis 20 ans. Ces céphalées sont épisodiques, de durée variable qui peut aller jusqu'à 2 jours. La patiente rapporte que ces épisodes surviennent en période menstruelle, associés à des vomissements et parfois des troubles visuels à type de lignes brisées scintillantes, qui durent 30 min juste avant le début des crises. Les céphalées sont décrites comme pulsatiles, hémicrâniennes et d'intensité modérée.

68. Quel est le diagnostic le plus probable ?

- A. Une migraine avec aura visuelle
- B. Des céphalées de tension
- C. Une anémie
- D. Une maladie de Horton
- E. Une sinusite chronique

Un an après, la patiente consulte aux urgences pour des céphalées qu'elle décrit comme inhabituelles installées 2 heures avant, en coup de tonnerre, atroces associées à des vomissements incoercibles.

69. Devant ces nouvelles plaintes, vous devez évoquer en premier

- A. Une crise de migraine sévère
- B. Des céphalées de tension
- C. Une hémorragie sous arachnoïdienne
- D. Des céphalées par abus médicamenteux
- E. Une anémie

70. Quelle serait votre conduite à tenir ?

- A. Rassurer la patiente et l'adresser à la consultation externe de neurologie
- B. Réaliser un scanner cérébral sans injection de produit de contraste
- C. Demander un fond d'œil
- D. Prescrire un traitement antalgique
- E. Réaliser un dosage de la ferritine

Cas clinique 2 :

Patient âgé de 75 ans aux antécédents d'HTA et de diabète mal équilibrés consulte pour une lourdeur de l'hémicorps droit et troubles du langage de survenue brutale à 5 heures du matin. L'examen neurologique trouve une hémiplégie droite à prédominance brachio-faciale et une aphasie de Broca. Le scanner cérébral fait en urgence est revenu sans anomalie.

71. Avant d'entamer la thrombolyse en IV, il est impératif :

- A. D'équilibrer les chiffres glycémiques
- B. D'équilibrer les chiffres tensionnels



71. Avant d'entamer la thrombolyse en IV, il est impératif :

- A. D'équilibrer les chiffres glycémiques
- B. D'équilibrer les chiffres tensionnels
- C. De vérifier les antécédents et les prises médicamenteuses du patient
- D. D'attendre les résultats de l'ionogramme sanguin
- E. D'obtenir le consentement accordé par le patient ou sa famille

72. Chez ce patient, le bilan étiologique de cet AVC ischémique doit rechercher en premier lieu :

- A. Une sténose carotidienne secondaire à l'athérosclérose
- B. Une dissection carotidienne
- C. Une fibrillation auriculaire
- D. Des troubles de l'hémostase d'origine congénitale
- E. Une angéite cérébrale

73. La prise en charge à la phase aigüe de ce patient consiste à :

- A. Mettre le patient sous insulinothérapie sous-cutanée si glycémie > 1,8 g/L
- B. Rechercher systématiquement les troubles de la déglutition
- C. Baisser la PA systolique si les chiffres dépassent 140 mm Hg
- D. Prescrire une anticoagulation à dose curative
- E. Démarrer la kinésithérapie motrice

Cas clinique 3

Enfant âgé de 7 ans aux antécédents familiaux d'épilepsie présente des épisodes pluriquotidiens survenant en classe fait d'arrêt de l'activité, perte de contact, regard dans le vide de quelques secondes de durée. L'examen neurologique est sans anomalies.

74. En faveur d'une épilepsie absence de l'enfant :

- A. Age de début
- B. Antécédent familiaux d'épilepsie
- C. Type des crises
- D. Normalité de l'examen neurologique
- E. La survenue en classe

75. Quel examen complémentaire demandez-vous ?

- A. IRM cérébrale
- B. Electroencéphalogramme
- C. Electrocardiogramme
- D. Bilan biologique
- E. Electromyogramme

76. L'évolution se fait dans la majorité des cas vers :

- A. La disparition des crises
- B. Le changement de type des crises
- C. L'augmentation de la fréquence des crises
- D. Une régression psychomotrice
- E. L'apparition de signes neurologiques



Cas clinique 4

Un homme de 32 ans, opéré d'une insuffisance aortique il y a deux ans, est porteur d'une prothèse valvulaire mécanique. Il se soumet à une surveillance régulière.

Son état est satisfaisant et l'auscultation (depuis l'intervention) était celle normalement rencontrée chez un porteur de prothèse aortique.

Depuis une extraction dentaire réalisée 3 semaines auparavant, il présente une fièvre à 38,5 degrés avec une asthénie.

77. le diagnostic que vous évoquez en premier est

- A. embolie pulmonaire
- B. péricardite aiguë
- C. infarctus du myocarde
- D. **endocardite infectieuse**
- E. dissection aortique

78. L'un des éléments suivants, s'il est retrouvé à l'auscultation, possède une grande valeur d'orientation diagnostique

- A. Une arythmie
- B. Un frottement péricardique
- C. Un souffle systolique
- D. Un bruit de galop
- E. **L'apparition d'un souffle diastolique**

79. Parmi les examens biologiques suivants, lequel doit être demandé en priorité ?

- A. Numération formule sanguine
- B. **Hémocultures**
- C. Amylasémie
- D. Enzymes cardiaques
- E. Gaz du sang

80. Compte tenu de la porte d'entrée, le germe le plus probablement en cause est

- A. Staphylocoque aureus
- B. Coxiella burnetii
- C. **Streptocoque viridans**
- D. Pneumocoque
- E. Bacille à Gram négatif

81. Le traitement antibiotique à indiquer en première intention est

- A. Ampicilline
- B. **Ampicilline + Oxacilline + gentamicine**
- C. Vancomycine
- D. Oxacilline + gentamicine
- E. Aucun traitement en attendant le résultat des hémocultures



Cas clinique 5

Un patient âgé de 27 ans, présente depuis 4 mois une hypoacousie

Cas clinique 5

Un patient âgé de 27 ans, présente depuis 4 mois une hypoacousie gauche. L'examen physique met en évidence une adénopathie spinale haute gauche, de 2 cm de diamètre, fixée aux plans profonds. L'état général est conservé.

82. **Le premier diagnostic évoqué est:**

- A. Un kyste amygdaloïde
- B. Une tumeur de la parotide, avec adénopathie métastatique
- C. Une mastoïdite aigue
- D. **Un cancer du cavum avec adénopathie métastatique**
- E. Un carcinome de la base de langue avec adénopathie métastatique

83. **Pour étayer ce diagnostic, l'examen suivant est indispensable**

- A. Une biopsie de la base de langue
- B. **Une nasofibroscopie avec biopsie**
- C. Un dosage des anticorps dirigés contre le virus Epstein-Barr
- D. Une sialographie
- E. Une otoscopie

84. **Les 2 examens nécessaires dans le cadre du bilan de sa surdité sont**

- A. **Impédancemétrie**
- B. **Audiométrie**
- C. Oto-émission-acoustique
- D. Potentiel évoqué auditif
- E. Electro-nystagmographie

85. **Les examens complémentaires qui font partie du bilan d'extension de la maladie sont**

- A. **IRM du cavum**
- B. **Scintigraphie osseuse**
- C. Scanner cérébral
- D. Scanner des rochers
- E. **Scanner thoracique**

86. **Le traitement semble le plus adapté à la pathologie de ce patient est**

- A. Chirurgie
- B. Chimiothérapie
- C. Radiothérapie
- D. Chirurgie puis radiothérapie
- E. **Radio-chimiothérapie concomitante**

Cas clinique 6

Mme S, âgée de 40 ans, tabagisme 2 Paquets /Année occasionnel, sans antécédents pathologiques notables, sous traitement contraceptif oral consulte son médecin de travail pour des céphalées récentes. L'examen clinique trouve une pression artérielle à 145/95 mmHg après un repos de

clinique trouve une pression artérielle à 145/95 mmHg après un repos de 5 minutes et contrôlée après 20 minutes. Cette pression artérielle est symétrique aux 2 bras et la fréquence cardiaque est à 86 cycles/mn. Le reste de l'examen clinique est normal.

Poids 68Kg, taille 1m70. Glycémie à 5 mmol/l cholestérol total 1,6g/l ,LDL Cholestérol 0,90 g/l ,HDL Cholestérol 0,7 g/l ,TG 1,3g/l

87. Devant cette hypertension artérielle quelle est l'attitude à suivre :

- A. Vous prescrivez un traitement hypertenseur à commencer le même jour
- B. Vous commencez un bilan biologique de cette hypertension avec la mise en route d'une bithérapie anti hypertensive
- C. Vous allez demander à la patiente de revenir en consultation pour une nouvelle prise tensionnelle après 3 mois
- D. Vous commencez par les mesures hygiéno-diététiques, arrêt du contraceptif oral avec une évaluation de la PA après 3 mois avec MAPA
- E. Vous rassurez la patiente car il s'agit d'une hypertension artérielle blouse blanche

88. Devant cette hypertension artérielle chez cette jeune femme, il faut rechercher une hypertension artérielle secondaire. Vous recherchez en particulier :

- A. la palpation des pouls fémoraux
- B. L'auscultation des artères rénales
- C. Rechercher des signes d'hypothyroïdie
- D. Recherche de souffle carotidien
- E. La notion de prise de psychotrope

89. Parmi les examens suivants quels sont ceux qui vont figurer dans le bilan que vous allez demander une fois l'HTA grade I est confirmée par la MAPA ?

- A. Ionogramme sanguin
- B. Recherche Protéinurie à la bandelette urinaire
- C. Bilan hépatique
- D. Echocardiographie
- E. Scanner abdominal

90. Parmi les propositions suivantes, quelles sont celles que vous retiendrez pour cette patiente ?

- A. La prise de contraceptif a pu révéler cette hypertension artérielle
- B. Le tabagisme même modéré associé à la prise de contraceptifs majore le risque cardiovasculaire
- C. Vous renouvelez l'ordonnance de contraceptif oral
- D. Il s'agit d'une HTA grade 1 avec un risque cardiovasculaire faible
- E. Un traitement antihypertenseur par une bithérapie doit être commencé d'emblée

91. Le traitement de cette hypertension artérielle doit associer



91. **Le traitement de cette hypertension artérielle doit associer**

- A. **Un IEC**
- B. **Un RAI**
- C. Un antihypertenseur central
- D. RAI + Diurétique thiazidique
- E. Un IEC + Un inhibiteur calcique

Cas clinique 7

Patiente âgée de 60 ans, diabétique et hypertendue, ayant des antécédents de cancer digestif sous chimiothérapie, consulte aux urgences pour douleur basithoracique gauche associée à une dyspnée aiguë

L'examen cardiovasculaire : trouve une : TA : 86/60 mm Hg, FC : 114 bat/mn, pas de souffle à l'auscultation, une Turgescence des veines jugulaires et un reflux hépato-jugulaire

ECG: RRS 114 cycles/mm, BBD complet, Hypertrophie ventriculaire droite, onde T négative en V1 et V2

92. **Le diagnostic à évoquer en première intention est**

- A. Péricardite aiguë avec tamponnade
- B. **Embolie pulmonaire grave**
- C. Syndrome coronarien aigu ST+ étendu vers le ventricule droit
- D. Syndrome coronarien aigu avec insuffisance mitrale ischémique importante
- E. une dissection de l'aorte

93. **Les examens complémentaires à demander pour confirmer votre diagnostic sont**

- A. **Une échocardiographie doppler cardiaque**
- B. Dosage des D dimères
- C. Dosage des troponines
- D. **Un Angioscanner thoracique**
- E. **Une Scintigraphie myocardique de perfusion et de ventilation**

94. **La conduite à tenir thérapeutique après confirmation diagnostique doit associer**

- A. **Hospitalisation en USIC**
- B. **Une anticoagulation par Héparine non fractionnée voie IV à doses préventives**
- C. Une anticoagulation par antivitamine K seule d'emblée sans relai par héparine
- D. **Une thrombolyse en urgence par rt-PA après avoir éliminé les contre-indications de la thrombolyse**
- E. **Commencer d'emblée par un nouveau anticoagulant oral**

95. **La patiente sort quelques jours plus tard sous AVK. Quelles propositions sont justes dans le cadre du traitement par AVK**

- A. **INR cible entre 2 et 3**
- B. Toujours associé à de l'aspegic 100 1 sachet/j pendant 1 semaine



- B. Toujours associé à de l'aspegic 100 1 sachet/j pendant 1 semaine
- C. Objectif de TP entre 60 et 80 %
- D. **Consigner les différents INR dans un carnet de surveillance**
- E. **Contre-indication à la prise d'AINS**

Cas clinique 8

Un homme âgé de 68 ans tabagique 70 PA non sevré, consulte en urgence pour dyspnée d'aggravation progressive depuis 15 jours.

L'interrogatoire retrouve qu'il est suivi depuis de nombreuses années pour BPCO post-tabagique GOLD B3 (GOLD 2017), il reçoit comme traitement de fond : salbutamol (Ventoline®) si besoin. budésonide+formotérol (Symbicort®) 400 µg x2/j.

Il est limité dans ses activités quotidiennes en raison d'une dyspnée d'effort stade 1 mMRC. Il décrit une toux avec des expectorations « verdâtres » depuis 10 jours et une majoration de l'abondance de celles-ci.

Il s'agit d'un patient vivant seul à son domicile sans enfants. Ses antécédents sont une cardiopathie ischémique avec mise en place d'un stent actif il y a 5 mois, une hypertension artérielle, une dyslipidémie, un diabète non insulino-dépendant et un alcoolisme chronique. Sur le plan clinique : température 37.9°C, FR : 23 cpm, SpO2 89%, FC : 95 bpm, PA 140/90 mmHg, quelques sibilants bilatéraux à l'auscultation pulmonaire, des œdèmes des membres inférieurs,. La radiographie thoracique montre des signes de distension thoracique.

La gazométrie artérielle en air ambiant est la suivante : pH 7,39 ; PaCO2 49 mmHg; PaO2 54 mmHg, HCO3 - 30 mmol/L ; SaO2 88%.

96. Ce tableau clinique évoque le diagnostic suivant :

- A. Une poussée d'insuffisance cardiaque droite
- B. Une poussée d'insuffisance cardiaque gauche
- C. Une décompensation d'une insuffisance respiratoire chronique
- D. Une embolie pulmonaire
- E. **Une exacerbation sévère d'une BPCO post-tabagique**

97. La prise en charge thérapeutique comporte :

- A. **Une antibiothérapie par voie générale**
- B. Une ventilation mécanique
- C. **Des nébulisations de broncho-dilatateurs**
- D. **Une oxygénothérapie**
- E. Une anticoagulation curative

L'évolution était favorable et à distance de cet épisode, le patient a été revu à la consultation externe, une spirométrie demandée a montré : un VEMS à 1000 ml (40%) et à 1020 ml (41%) après bronchodilatation, la CVF est à 2300 ml (70%) avant bronchodilatation et 2400 ml (74%) après bronchodilatation et VEMS/CFV post-bronchodilatation à 43%.

98. Selon vous on pourra classer la maladie en stade :

- A. Gold B3
- B. Gold B4
- C. **Gold D3**
- D. Gold D1
- E. Gold D2

99. La prise en charge thérapeutique au long cours comportera le ou les éléments suivants :

- A. **Bronchodilatateurs de courte durée si besoin**
- B. **Le sevrage tabagique**
- C. Une association $\beta 2$ mimétiques de longue durée d'action et anticholinergiques de longue durée d'action et corticoïdes inhalés d'emblée
- D. Un $\beta 2$ mimétique de longue durée d'action en monothérapie
- E. **Une association de bronchodilatateurs de longue durée d'action**

Cas clinique 9

Un patient âgé de 65 ans, fumeur 50 PA, consulte pour dyspnée d'effort avec gonflement récent du cou et un amaigrissement de 4 kg en 3 mois

L'examen physique trouve un comblement du creux sus claviculaire droit et une circulation collatérale thoracique.

La radiographie du thorax montre une opacité médiastino-parenchymateuse hilaire et latéro-trachéale droite

100. Le tableau radio-clinique peut faire évoquer :

- A. Une sarcoïdose médiastino-pulmonaire
- B. **Un lymphome malin**
- C. **Un cancer bronchique primitif**
- D. Une tuberculose
- E. **Des métastases**

101. La fibroscopie bronchique montre une infiltration bourgeonnante de la lobaire supérieure droite, cet examen permet en plus de :

- A. **Noter l'aspect des cordes vocales**
- B. **Préciser la distance de la lésion par rapport à la carène**
- C. **Faire des biopsies**
- D. **Faire des cytologies à la recherche de cellules néoplasiques**
- E. Confirmer l'envahissement de la veine cave supérieure

102. La biopsie de la lésion a mis en évidence un adénocarcinome bronchique, le bilan d'extension va comporter :

- A. **Un scanner thoracique**
- B. **Un scanner cérébral**
- C. Un dosage des marqueurs tumoraux
- D. **Une échographie abdominale**
- E. Un PET scanner



L'examen TDM thoracique a objectivé une tumeur du lobe supérieur droit de 5 cm de diamètre avec adénopathies médiastinales latéro-trachéales droites et envahissement de la veine cave supérieure. Le reste du bilan d'extension est négatif.

103. La classification TNM sera :

- A. T3N2M0
- B. T3N1M0
- C. **T4N2M0**
- D. T4N3M0
- E. T3N2M1

Cas clinique 10

Mme S D âgée de 42 ans G5P0 enceinte à 35 SA d'une grossesse gémellaire post fécondation in vitro consulte aux urgences de l'hôpital de circonscription pour un flou visuel associé à des céphalées. Vous suspectez une pré-éclampsie compliquée de signes neuro-sensoriels.

104. Quels sont parmi ces éléments de l'anamnèse qui orientent vers une pré éclampsie ?

- A. Un antécédent de migraine
- B. **Un antécédent de 4 pertes fœtales**
- C. La notion de syndrome polyuro-poly-dipsique
- D. Un **antécédent de thrombose veineuse profonde**
- E. **Une prise de poids de 5 kg au cours de la dernière semaine de grossesse**

L'anamnèse est peu contributive car la patiente devient agitée en rapport avec une douleur abdominale aiguë. Par ailleurs, TA 17/10 contrôlée aux deux bras avec une protéinurie à la bandelette à 3 croix.

105. Quelles sont les causes possibles de ces douleurs abdominales aiguës chez cette patiente en rapport avec sa pré-éclampsie ?

- A. Un HELLP syndrome
- B. Une nécrose corticale
- C. Une prématurité induite
- D. **Un hématome rétro placentaire**
- E. **Un hématome sous capsulaire du foie**

106. Quelles sont les mesures que vous prenez immédiatement aux urgences ?

- A. **Sondage vésical**
- B. **Double voie veineuse**
- C. Echographie obstétricale
- D. **Célestène 12 mg en intra-musculaire**
- E. Sulfate de magnésium 1g/ heure en pousse seringue

Vous décidez de transférer la patiente vers l'hôpital universitaire de la région.

107. Quels sont les éléments fœtaux de gravité à transmettre au médecin néonatalogiste qui va réceptionner le transfert in



107. Quels sont les éléments fœtaux de gravité à transmettre au médecin néonatalogiste qui va réceptionner le transfert in utero ?

- A. Une hauteur utérine à 36 cm
- B. Un virage du liquide amniotique
- C. Une grande citerne amniotique à 1 cm
- D. Un notch bilatéral au Doppler de l'artère utérine
- E. Une stagnation du périmètre abdominal depuis 15 jours

Cas clinique 11

Mr J A âgé de 56 ans consulte pour une dysphagie évoluant depuis 2 mois. Il est diabétique et hypertendu. Il a présenté il y a 7 ans une symptomatologie de reflux gastro-oesophagien (RGO) pour laquelle il a eu un traitement par inhibiteurs de la pompe à protons (IPP) avec une amélioration partielle. Sa dysphagie est apparue progressivement depuis 2 mois, notamment pour les solides. Il se sent plus fatigué et il a remarqué avoir perdu quelques kilos.

108. Les éléments qui orientent vers une dysphagie lésionnelle chez ce patient sont:

- A. L'électivité pour les solides
- B. L'amélioration sous IPP
- C. L'évolution progressive
- D. Le retentissement sur l'état général
- E. La présence d'une symptomatologie de RGO

109. Quel examen demandez-vous chez ce patient ?

- A. Manométrie oesophagienne
- B. pH-métrie oesophagienne
- C. Transit oesophagien
- D. Fibroscopie oeso-gastroduodénale
- E. Scanner Thoraco-abdominal

110. Les diagnostics à évoquer chez ce patient sont

- A. Œsophagite peptique
- B. Sténose peptique de l'oesophage
- C. Cancer du pancréas
- D. Achalasie de l'oesophage
- E. Adénocarcinome de l'oesophage

111. Le diagnostic le plus probable chez ce patient est

- A. Œsophagite peptique
- B. Sténose peptique
- C. Endobrachy-oesophage (EBO)
- D. Carcinome épidermoïde de l'oesophage
- E. Adénocarcinome de l'oesophage

Cas clinique 12

Une femme âgée de 55 ans, consulte pour ictère avec urines foncées et selles décolorées associées à des douleurs épigastriques. A L'examen



physique on trouve: un ictère conjonctival, une température à 37°, une grosse vésicule palpable. Le bilan biologique montre: bilirubine totale= 90 $\mu\text{mol/l}$; bilirubine conjuguée= 75 $\mu\text{mol/l}$, phosphatases alcalines= 320UI/l (N<91), gammaglutamyl transférase= 400UI/l (N<50), ALAT=80UI/l(N<40), ASAT=66 UI/l (N<36). L'échographie abdominale trouve une dilatation des voies biliaires intra et extra-hépatiques sans obstacle évident.

112. Parmi les éléments cliniques et biologiques suivants, ceux qui orientent vers la nature cholestatique de l'ictère sont

- A. Urines foncées
- B. Douleurs de l'hypochondre droit
- C. Absence de prurit
- D. Élévation des phosphatases alcalines
- E. Élévation des ALAT

113. La grosse vésicule palpable témoigne d'un obstacle :

- A. Extra-hépatique
- B. Au niveau du corps du pancréas
- C. Au niveau du hile hépatique
- D. Au niveau du cholédoque
- E. Au dessus de l'abouchement du canal cystique

114. Les étiologies probables à l'origine de ce tableau sont :

- A. Cancer de la vésicule biliaire
- B. Cancer du pancréas
- C. Hépatite virale
- D. Cholangite biliaire primitive
- E. Ampullome vatérien

115. A ce stade, quels sont les examens complémentaires que vous pouvez demander :

- A. Scanner abdominal
- B. Cholangio-pancréato-IRM
- C. Cholangiographie pancréatique rétrograde
- D. Echo-endoscopie
- E. Ponction biopsie hépatique

Cas clinique 13

Un patient âgé de 45 ans alcoolique chronique vient vous consulter pour ictère. Cet ictère est apparu il y a 48 heures après une grippe qui a duré une semaine. A l'examen clinique, le patient est comateux, apyrétique sans hépatomégalie ni de splénomégalie.

Le bilan biologique montre :

Bilirubines totales : 40 micromoles/l
 $\mu\text{mol/l}$

Bilirubines conjuguée : 36

ALAT : 1400UI/l (N<40), ASAT : 1200 UI/l (N<50)
:340 $\mu\text{mol/l}$ (N<306)

Phosphatase alcaline

Numération formule sanguine normale

Taux de prothrombine : 20%

Bilirubines totales : 40 micromoles/l
 $\mu\text{mol/l}$

Bilirubines conjuguée : 36

ALAT : 1400UI/l (N<40), ASAT : 1200 UI/l (N<50) Phosphatase alcaline : 340 $\mu\text{mol/l}$ (N<306)

Numération formule sanguine normale Taux de prothrombine : 20%
Facteur V : 22%

Le bilan sérologique montre un Ag HBs positif, des anti HBc de type Ig M positifs et des anti VHC négatifs.

116. Quels sont les éléments clinico-biologiques qui indiquent l'hospitalisation en urgence du patient ?

- A. Bilirubines totales : 40 micromoles/l
- B. ALAT : 1400UI/l
- C. Phosphatase alcaline : 340 $\mu\text{mol/l}$
- D. Taux de prothrombine : 20%
- E. Facteur V : 22%

117. Le diagnostic le plus probable devant ce tableau clinique est

- A. Hépatite chronique C
- B. Hépatite alcoolique aiguë
- C. Cirrhose
- D. Carcinome hépatocellulaire
- E. Hépatite B aiguë

118. Le taux de mortalité spontanée de ce tableau est

- A. 20 %
- B. 30%
- C. 5 %
- D. 15 %
- E. Plus que 80 %

Cas clinique 14

Une patiente âgée de 25ans, consulte pour une diarrhée faite de 5 à 6 selles /24h diurnes et nocturnes, luisantes et collant à la cuvette, évoluant depuis 6 mois, associée à un amaigrissement de 5 kg. Pas de notion de prise médicamenteuse.

Examen physique : pâle, ongles mous et cassants, signe de chvostec positif, IMC: 18 kg/m²

Biologie : Hb=9g/dl, VGM=70, TCMH=25pg, GB=8500/mm³, plaquettes=200 000/mm³, CRP=5mg/l, Albumine=30g/l, TP=65%, calcémie=2mmol/l, cholestérolémie = 3mmol/l (N : 3,7 - 6,2). La stéatorrhée est à 18 g/24h.

Une fibroscopie avec des biopsies duodénales est réalisée.

A l'examen histologique : atrophie villositaire subtotale associée à une hyperplasie des cryptes. Les lymphocytes intra-épithéliaux sont nombreux et le chorion est occupé par des lymphocytes, plasmocytes et polynucléaires éosinophiles. Une hyperplasie des glandes de Brunner est observée.



119. Les éléments qui vous permettent de retenir le diagnostic d'une diarrhée chronique:

- A. 5 à 6 selles /24h
- B. Evolution depuis 6 mois
- C. Hémoglobine = 9g /dl
- D. TP = 65%
- E. Albumine=30 g/l

120. Quel serait le mécanisme de la diarrhée chez cette patiente?

- A. Malabsorption
- B. Motrice
- C. Volumogénique
- D. Osmotique
- E. E- Sécrétoire

121. Le premier diagnostic à évoquer devant ce tableau clinique est :

- A. Maladie de Crohn
- B. Maladie de Whipple
- C. Lymphome du grêle
- D. Giardiase
- E. Maladie coéliquae

122. Pour confirmer le diagnostic, on demande:

- A. Sérologie de la maladie coéliquae
- B. Scanner abdominal
- C. Biopsies duodénales
- D. Coloscopie
- E. Examen copro parasitologique des selles

Cas clinique 15

Madame L, 40 ans, G4P4A0, sans antécédents ni moyens contraceptifs particuliers, utilise parfois la méthode d'abstinence périodique, vous consulte rapportant la notion de rapport à J9, réalisant le risque de grossesse, elle vient demander votre conseil pour une contraception d'urgence.

123. La méthode du calendrier

- A. a été respectée par la patiente vu l'éviction entre J10 et J 18
- B. est appelée aussi méthode Billings
- C. est appelée aussi méthode Ogino-Knaus
- D. a un indice de PEARL à 1,5

E. 150 grossesses sont obtenues si 1000 femmes utilise cette méthode pendant un an.

124. La contraception d'urgence

- A. est non justifiée à J 9
- B. est d'ordre hormonal, essentiellement progestative
- C. hormonale, elle comprend des oestroprogestatifs à forte dose
- D. hormonale, elle comprend des progestatifs à forte dose
- E. Comprend le recours au DIU

125. Le Norlévo ®

- A. est un progestatif de 2^{ème} génération
- B. peut être administré et aussi efficace jusqu'au 5^{ème} jour suite à un rapport à risque
- C. comprend 1, 5 mg de lévonorgestrel
- D. est moins efficace que le Ellaone®
- E. est plus efficace que le DIU

126. Le DIU

- A. est le moyen contraceptif d'urgence le plus efficace
- B. à poser dans la semaine suite au rapport à risque
- C. est souhaitable chez l'adolescente
- D. à garder comme moyen contraceptif chez cette patiente
- E. agit par effet inflammatoire sur l'endomètre et toxique sur le spermatozoïde

127. Après la contraception d'urgence

- A. conseiller un oestroprogestatif minidosé chez cette patiente
- B. conseiller un DIU
- C. Refaire un bilan hormonal avant d'instaurer une contraception chez cette patiente
- D. un microprogestatif est la méthode de choix chez cette patiente sachant qu'elle a eu un antécédent de phlébite du membre inférieure
- E. le DIU est moins efficace que les microprogestatifs

Fin de l'épreuve